

Дата: 03.02.2025

Полис ОМС: 2988299720000033

Место приема : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии - Клиника доктора Рошаля Департамента здравоохранения города Москвы

Врач: ВОРОБЬЕВ Д. А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОТЛОЖНОЙ ДЕТСКОЙ
ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ - КЛИНИКА ДОКТОРА РОШАЛЯ" ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ИБ № 2510-25-С

03.02.2025 ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице

Отделение: Травматологическое отделение.

Дата поступления в стационар: 18.01.2025 г., 23:55.

Пациент находился: с 19.01.2025 г., 0:04 - Травматологическое отделение.

Дата выписки из стационара: 03.02.2025 г., 11:32.

Кол-во койко-дней: 16 дней.

Диагноз при выписке

Основной диагноз: M25.3 Другая нестабильность сустава.

Рассекающий остеохондрит латеральной фасетки, гребня надколенника ICRS IVст. Импрессионный перелом медиального края надколенника с наличием свободных хрящевых фрагментов в полости сустава. Импрессионный перелом латерального мыщелка бедренной кости. Разрыв медиальной пателлофemorальной связки у надколенника и у бедренной кости. Разрыв медиального ретинакулюма у надколенника с фиксированными Kхр фрагментами надколенника. Растяжение медиальной коллатеральной связки, широких мышц бедра. Раеа аа. Латерализация бугристости большеберцовой кости. Гиперпрессия латеральной фасетки надколенника. Гемартроз левого коленного сустава. Состояние после вывиха надколенника.

Анамнез заболевания

Со слов: мальчика, в 2020г. в время бега стала беспокоить боль в левом коленном суставе, затем в правом. Болевой синдром прогрессировал, с 2022г. Появился хруст, преимущественно в левом коленном суставе. С 2023г. отмечает боль в коленях при подъеме и спуске по лестницам. 18.01.2025г. поскользнулся на льду, всем весом оперся на левую ногу, произошел вывих надколенника. .

Инструментальные исследования

Магнитно-резонансная томография коленного сустава.

Дата исследования: 20.01.2025 г.

Описание: Заключение: МРТ картина состояния после острого вывиха надколенника левого коленного сустава: импрессионный перелом передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости и ниже-медиального края надколенника остеохондральное повреждение гребня и медиальный фасетки надколенника с формированием свободного хрящевого фрагмента (на момент исследования: у верхних отделов медиальной фасетки надколенника) признаки полного разрыва медиального ретинакулюма у надколенника с авульсией фрагмента кортикального слоя от ниже-медиальной поверхности надколенника частичного повреждения медиальной пателло-фemorальной связки у надколенника и у бедренной кости растяжение медиальной коллатеральной связки, широких мышц бедра гемартроз посттравматический синовит. МРТ признаки высокого стояния надколенника латерализации бугристости большеберцовой кости дисплазии блока бедренной кости (тип А по Dejour)..

Магнитно-резонансная томография коленного сустава.

Дата исследования: 20.01.2025 г.

Описание: Заключение: МРТ картина хондромалиции медиальной фасетки надколенника с отеком костной ткани и формированием субхондральных кист (вероятно, IV ст по классификации по Ouerbridge). Отек в верхнелатеральных отделах жирового тела Гоффа правого коленного сустава — может соответствовать проявлениям импиджмент синдрома (при сопоставлении с клинической картиной). МРТ признаки высокого стояния надколенника латерализации бугристости большеберцовой кости дисплазии блока бедренной кости (тип А по Dejour)..

Компьютерная томография коленных суставов.

Дата исследования: 19.01.2025 г.

Описание: Исследование выполнено не под углом 30 градусов: Индекс TT-TG справа 24,0 мм слева – 22,0 мм. Индекс Insa-Savai справа — 1,4 (Раеа аа) слева – 1,32 (Раеа аа). Правый коленный сустав без костно-травматических изменений.. Заключение: Состояние после вывиха левого надколенника. Остеохондральное повреждение медиального края и медиальной фасетки надколенника слева. Импрессионное повреждение суставной поверхности передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости справа. Рассекающий остеохондрит латеральной фасетки левого надколенника 4 стадии (болезнь Кенига). Раеа аа. Гемартроз левого коленного сустава. Ушиб жирового тела Гоффа слева. Дисплазии блока бедренных костей (тип В по Dejour)..

Магнитно-резонансная томография коленного сустава.

Дата исследования: 31.01.2025 г.

Операции

A16.04.015: Артроскопия левого коленного сустава, удаление свободных и фиксированных к/хр фрагментов надколенника. Артротомия, иссечение патологического участка, микрофрактурирование и хондропластика участка асептического некроза надколенника с использованием JoinRep. Пластика МПФЛ аутосухожилием m.semiindinosus, медиализация и дистализация бугристости большеберцовой кости, парциальный латеральный релиз, пателлопластика.. 24.01.2025 г.
Наличие осложнений: нет.

Заключение

Ортез не снимать, не мочить. ЛФК, разработка. Ходить на костылях без опоры на поврежденную конечность. Укрепление мышц бедра с упором на медиальную группу, ягодичных мышц - консультация врача ФЗТ в поликлинике по месту жительства - миостимуляция не менее 2 мес №10-15. Поднятие, отведение, приведение ног с эспандерами. При ухудшении состояния (подъем температуры, отек, боли) обратиться к врачу по месту жительства. Освободить от физкультуры на 6 мес. Обрабатывать швы бриллиантовым зеленым 1 раз в день, не мочить. При ухудшении состояния (подъем температуры, отек, боли) обратиться в 4 х/о. Явка в 4 х/о для снятия швов 07.02.2025 к 09:00. После снятия швов обработка рубцов Кео-сое гель 2 раза в день тонким слоем не менее 1 мес.

Рекомендации

Прочие рекомендации: Явка в кабинет долечивания НИИ НДХ и Т (травмпункт каб.119) 04.03.2025 10:00 ТОЛЬКО С РОДИТЕЛЕМ, НАПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ Департамента здравоохранения г. МОСКВЫ, с полисом и выпиской. Плановое лечение в НИИ НДХ и Т возможно по направлению из ПОЛИКЛИНИКИ Департамента здравоохранения г. Москвы, форма 057/у-04 в рамках ОМС (бесплатно), при отсутствии - прием платный. Перезапись по телефону 8-495-633-58-00, доб 1116/1713, с пн и ср с 14.00 до 15.00. Внимание Прием в порядке живой очереди.

Исход и результат госпитализации

Результат госпитализации: выписан из стационара.
Дополнительная информация: Послеоперационное течение гладкое, нейроциркуляторных нарушений нет, остеосинтез стабилен, начат курс ЛФК, швы состоятельны, воспалительных явлений нет, Рг контроль - удовлетворительный, нейроциркуляторных нарушений нет, поврежденная конечность фиксирована жестким ортезом, фиксация стабильна, ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Трудоспособность

Неприменимо.

Сведения о листке нетрудоспособности

Домашний режим 6 недель. домашний режим (справки и документы о домашнем обучении, больничные листы выдаются/продлеваются при обращении в ЛПУ по месту жительства со дня выписки из стационара).

Врач - травматолог-ортопед / _____/ **ВОРОБЬЕВ ДЕНИС
АНДРЕЕВИЧ**

Заведующий отделением / _____/ **НИКИШОВ СЕРГЕЙ
ОЛЕГОВИЧ**